



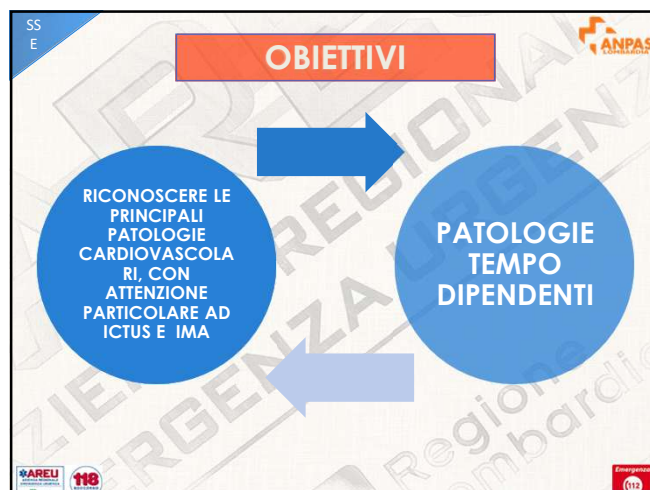


MODULO SSE
CAPITOLO 2

EMERGENZE MEDICHE
ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE
CARDIOCIRCOLATORIA
IMA E ICTUS

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU

SS E

EPIDEMIOLOGIA

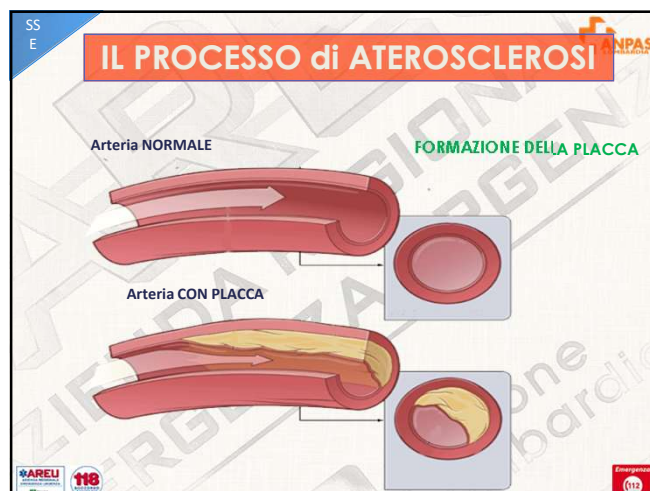
LE CARDIOPATIE ISCHEMICHE SONO LA PRIMA CAUSA DI MORTE IN ITALIA E RAPPRESENTANO IL 44% DI TUTTI I DECESSI ANNUI

Dati Dell'Istituto Superiore Sanità 2010



ANPAS

AREU 118 Emergenza 112



SS E

FATTORI DI RISCHIO

FUMO

ALTA PRESSIONE SANGUIGNA

COLESTEROLO ELEVATO

MANCANZA DI ATTIVITÀ FISICA

OBESITÀ

DIABETE

STRESS

STORIA FAMILIARE



ANPAS

AREU 118 Emergenza 112

SS E

PATOLOGIE PRINCIPALI

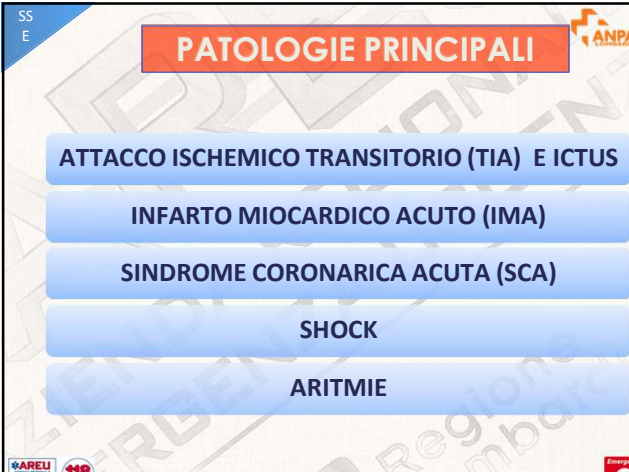
ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO (TIA) E ICTUS

INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA)

SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA)

SHOCK

ARITMIE



ANPAS

AREU 118 Emergenza 112

PATOLOGIE CEREBROVASCOLARI

ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO

ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA CON
SEGNI E SINTOMI CHE SCOMPAIONO ENTRO
LE 24 ORE
DAL LATINO ICTUS = COLPO (APOPLETTICO)
DALL' INGLESE STROKE = COLPO

SS E ANPAS

WAREL 118 Emergenza 112

PATOLOGIE CEREBROVASCOLARI

ICTUS

MALATTIA NEUROLOGICA AD ESORDIO
IMPROVVISO O RAPIDO (SECONDI, MINUTI)
DOVUTA AL DANNO DEL TESSUTO CEREBRALE
CONSEQUENTE AD UNA ALTERAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE CEREBRALE

3^A CAUSA DI MORTE NEL MONDO
1^A CAUSA DISABILITÀ NELL'ADULTO ≈
3% COSTI SOCIALI
INCIDENZA 2 X 1000 AB. X ANNO

SS E ANPAS

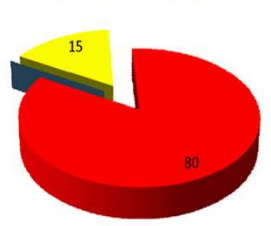
WAREL 118 Emergenza 112

TIPOLOGIA DI ICTUS

ISCHEMICO 80%
(ischemia = mancanza di
sangue)

EMORRAGICO 15%
(emorragia = spandimento di
sangue)

NON CLASSIFICABILE 5%

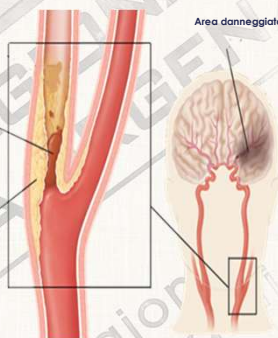


SS E ANPAS

WAREL 118 Emergenza 112

ICTUS ISCHEMICO

LA CHIUSURA DI UNA
ARTERIA CEREBRALE
RIDUCE IL FLUSSO
EMATICO AD UNA
REGIONE DEL CERVELLO
CAUSANDO LA MORTE
(NECROSI) DELLE CELLULE
CHE VENGONO
SOLITAMENTE ALIMENTATE
DAL VASO CHE SI È
CHIUSO



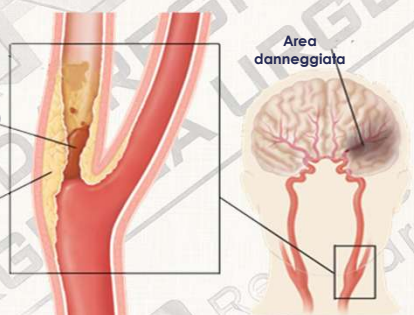
Area danneggiata
Trombo (coagulo)
Placca

SS E ANPAS

WAREL 118 Emergenza 112

TROMBOSI

IL COAGULO CHE CHIUDE L'ARTERIA NASCE NEL PUNTO
DELL'OCCULSIONE



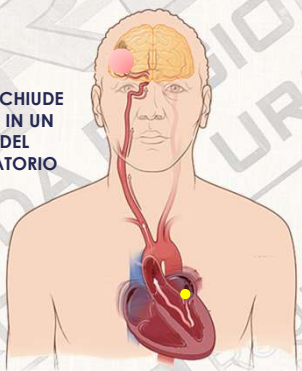
Area danneggiata
Trombo (coagulo)
Placca

SS E ANPAS

WAREL 118 Emergenza 112

EMBOLIA

IL COAGULO CHE CHIUDE
L'ARTERIA NASCE IN UN
ALTRO PUNTO DEL
SISTEMA CIRCOLATORIO



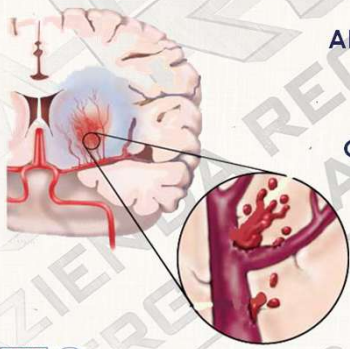
SS E ANPAS

WAREL 118 Emergenza 112

SS
E

ICTUS EMORRAGICO

LA ROTTURE DI UNA
ARTERIA INTRACRANICA
PROVOCA LA
FUORIUSCITA DI UNA
QUANTITÀ DI SANGUE
CHE DANNEGGIA IL
TESSUTO CEREBRALE
(CON DIVERSI MECCANISMI)



ANPAS

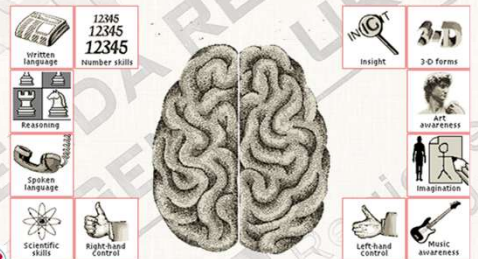
WAREU
118
Emergenza
012

SS
E

ICTUS

SINTOMI

NELLE MALATTIE CEREBRALI I DEFICIT RIFLETTONO LA SEDE
DELLA LESIONE NEL CERVELLO LE DIVERSE FUNZIONI (SENSO,
MOTO, COORDINAZIONE, COGNIZIONE, EMOZIONI) HANNO UNA
DIFFERENTE LOCALIZZAZIONE



ANPAS

WAREU
118
Emergenza
012

SS
E

**LOCALIZZAZIONI delle FUNZIONI
SPECIALIZZAZIONE EMISFERICA**

EMISFERO SIN :
FUNZIONI VERBALI
RAZIONALITÀ
ELABORAZIONE
"ANALITICA"



EMISFERO DX :
FUNZIONI VISUO-
SPAZIALI
EMOTIVITÀ
ELABORAZIONE
"SINTETICA"

ANPAS

WAREU
118
Emergenza
012

SS
E

ICTUS

SINTOMI

**ALTERAZIONE DELLA MOTILITÀ E/O SENSIBILITÀ DI
UNO O PIÙ DISTRETTI CORPOREI**

DISTURBI DEL LINGUAGGIO
(AFASIA, DISFASIA, DISARTRIA)

AMNESIA – DISTURBI VISIVI

DISTURBI DELL'EQUILIBRIO

DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE

PERDITA DEL CONTROLLO DEGLI SFINTERI

ANPAS

WAREU
118
Emergenza
012

SS
E

ICTUS

VALUTAZIONE

**VALUTAZIONE DELLA SCENA
«COLPO D'OCCHIO»**

A B C D E

A.M.P.I.A

ANPAS

WAREU
118
Emergenza
012

SS
E

ICTUS

**VALUTAZIONE DELLA SCENA
«COLPO D'OCCHIO»**

Ci sono buone probabilità che l'attacco ischemico
transitorio (tia) sia già regredito al nostro arrivo,
non si può dire altrettanto dell'ictus.

l'osservazione/colpo d'occhio fatta anche
sull'ambiente può darci già degli elementi ancor
prima della valutazione diretta sul paziente:

*linguaggio, posizione e motilità del
paziente*

ANPAS

WAREU
118
Emergenza
012

SS
E

ICTUS

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

A COSCIENZA

B RESPIRO

C FC, PA, COLORITO e TEMPERATURA CUTANEA

D AVPU, **SCALA DI CINCINNATI**

E VALUTAZIONE TESTA-PIEDI e A.M.P.I.A.

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Cincinnati Prehospital Stroke Scale

D **MIMICA FACIALE**
invitare il paziente a sorridere o mostrare i denti

NORMALE **ANORMALE**

SE ENTRAMBI I LATI DEL VISO SI MUOVONO ALLO STESSO MODO

SE UN LATO DEL VISO SI MUOVE DIFFERENTEMENTE RISPETTO ALL'ALTRO

DEVIATIONE RIMA LABIALE

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Cincinnati Prehospital Stroke Scale

D **SOLLEVAMENTO DELLE BRACCIA:**
invitare il paziente a chiudere gli occhi e sollevare le braccia

NORMALE **ANORMALE**

SE ENTRAMBI GLI ARTI SI MUOVONO ALLO STESSO MODO

SE UN ARTO CADE O SI MUOVE DIFFERENTEMENTE RISPETTO ALL'ALTRO

(SEGN DI LATO)

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Cincinnati Prehospital Stroke Scale

D **LINGUAGGIO:**
invitare il paziente a pronunciare una frase:

NORMALE: SE IL PAZIENTE LA PRONUNCIA CORRETTAMENTE

ANORMALE: SE IL PAZIENTE SBAGLIA LE PAROLE, LE STRASCICA, OPPURE NON EMETTE SUONO

SIGNORE, COME STA?

MI SENTO STRANO! ma quello chi è?

imm..bbs scii nnga

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

ICTUS

D **VALUTAZIONE neurologica : TERMINOLOGIA**

CALO DI FORZA = PARESÌ

ASSENZA DI FORZA = PARALISI/PLEGIA
MONOPARESÌ/PLEGIA (UN ARTO)
EMIPARESÌ/PLEGIA (ARTO SUP. E INF. DELLO STESSO LATO)

DISFUNZIONI DELLA PAROLA:
AFASIA NON PARLA MA CAPISCE
DISARTRIA DIFFICOLTÀ NELL'ARTICOLARE LE PAROLE

PARAPARESÌ/PLEGIA (ARTI INFERIORI)
TETRAPARESÌ/PLEGIA (TUTTI GLI ARTI)

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

ICTUS

A.M.P.I.A.

VALUTAZIONE

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ? PRIMO EPISODIO?

PATOLOGIE PREGRESSE ? FARMACI IN TERAPIA?

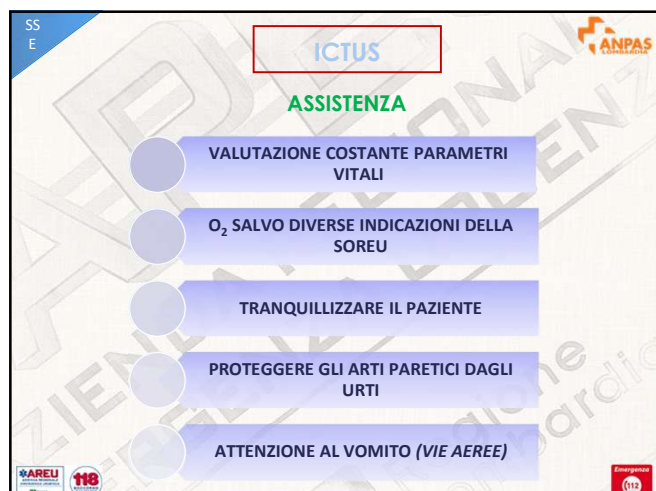
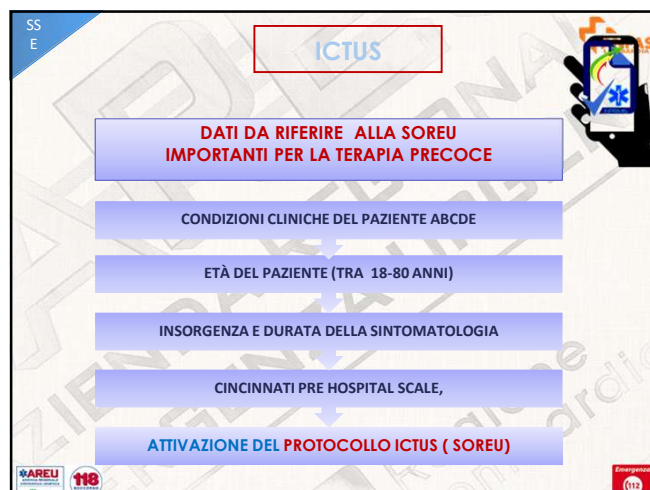
INIZIO ESATTO DELLA SINTOMATOLOGIA
PATOLOGIA TEMPO-DIPENDENTE

DOCUMENTAZIONE SANITARIA
RECENTE - AGGIORNATA - COMPLETA

ANPAS

118

Emergenza 112



SS
E

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

DOLORE TORACICO: INDAGINE



DA QUANTO TEMPO È INSORTO?
A RIPOSO O DOPO SFORZO ?
È LA PRIMA VOLTA?
È CARDIOPATICO?
HA ASSUNTO FARMACI?
CHE TIPO ?
VALUTAZIONE INTENSITÀ: 1-10

ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

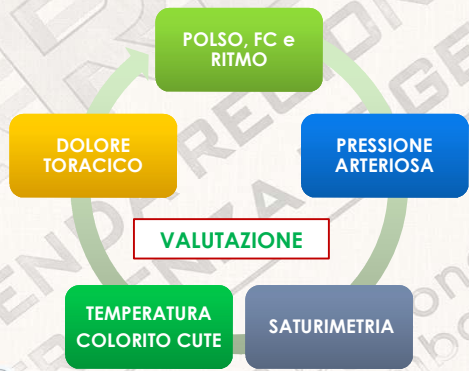
L'INFARTO È UNA **PATOLOGIA**
TEMPO-DIPENDENTE:
IL TEMPO È MUSCOLO (CARDIACO)




ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

INFARTO MIOCARDICO ACUTO



ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

PERCORSO STEMI



```

graph LR
    A[RICHIESTA DI SOCCORSO E FILTRO DELLA CHIAMATA] --> B[ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO E INVIO DEL MEZZO CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE ECG]
    B --> C[CONFERMA DEL SOSPETTO E INVIO DI ECG ALLA SOREU E CARDIOLOGIA DI RIFERIMENTO]
    C --> D[PRECOCHE ESECUZIONE DI ANGIOPLASTICA PRIMARIA PTCA]
    D --> E[INVIO PRESSO L'OSPEDALE CON EMOdinamica DISPONIBILE]
    E --> A
  
```

ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

SHOCK

DEFINIZIONE:

ALTERAZIONE DELL'EQUILIBRIO TRA LA QUANTITÀ DI SANGUE CHE ARRIVA AI TESSUTI IN RAPPORTO ALLA QUANTITÀ DI SANGUE CIRCOLANTE E LE NECESSITÀ DI OSSIGENO E SOSTANZE NUTRITIVE DEI TESSUTI STESSI

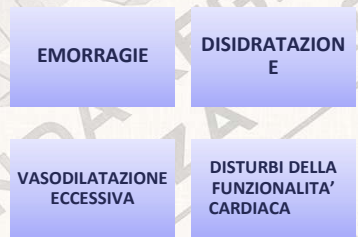
LA PERSISTENZA DI QUESTA CONDIZIONE PORTA A LESIONI IRREVERSIBILI DEGLI ORGANI E ALLA MORTE DEL PAZIENTE

ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

SHOCK CAUSE



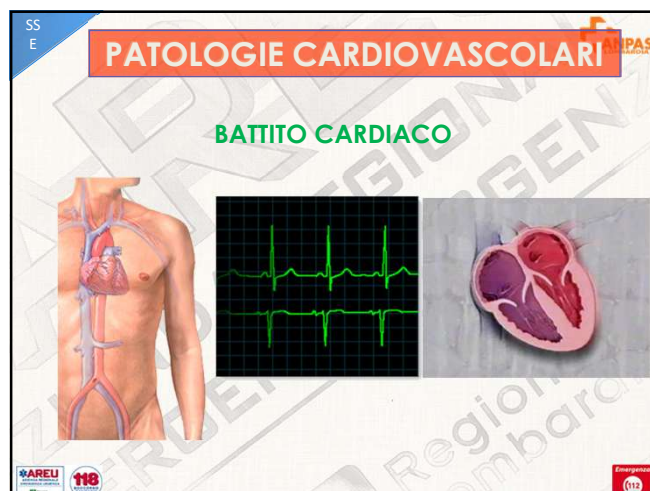
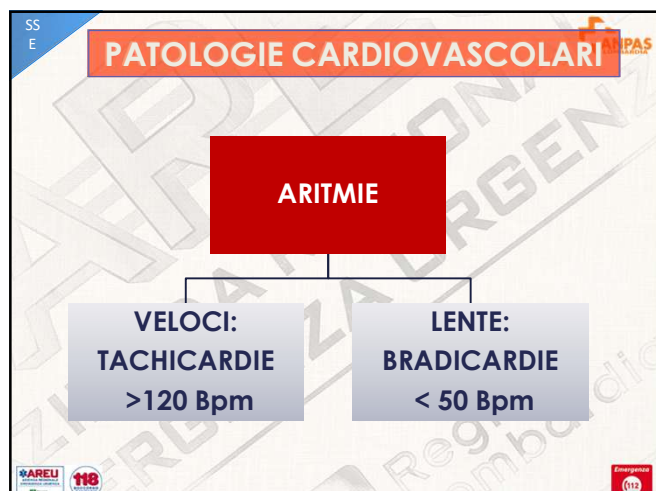
ARELU 118 Emergenza 112

SS E

TABELLA PARAMETRI SHOCK

PARAMETRI	SHOCK COMPENSATO	SHOCK SCOMPENSATO	SHOCK GRAVE
FREQUENZA CARDIACA	NORMALE O LIEVE AUMENTO (100 -120)	TACHICARDIA >120 Polso radiale flebile O ASSENTE	BRADICARDIA <50 polso radiale ASSENTE
PRESSIONE ARTERIOSA	NORMALE	IPOENSIONE <90	NON RILEVABILE
FREQUENZA RESPIRATORIA	TACHIPNEA	TACHIPNEA	DISPNEA BRADIPNEA
CUTE	NORMALE O FREDDA E UMIDA	PALLIDA, FREDDA, SUDATA	FREDDA, CIANOTICA, MAREZZATA
STATO DI COSCIENZA	NORMALE O ANSIÀ	STATO DI AGITAZIONE/CONFUSIONE	STATO SOPOROSO , INCOSCIENTE

ARELU 118 Emergenza 112



SS
E

ARITMIE

VALUTAZIONE e ASSISTENZA

-  IPOTENSIONE, SUDORAZIONE E PALLORE
-  VALUTARE LA PRESENZA DOLORE TORACICO
-  LE GRAVI ARITMIE POSSONO EVOLVERE IN MORTE IMPROVVISA
-  MONITORAGGIO ATTENTO E COSTANTE DEI PARAMETRI VITALI

CONTATTO TEMPESTIVO CON LA SOREU

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Valutazione Primaria

Al termine della fase "C" comunicare alla SOREU segni e sintomi che potrebbero compromettere la sopravvivenza della vittima.

Sulla base di tali comunicazioni la SOREU avrà la possibilità di fornire istruzioni adeguate all'equipaggio di soccorso

SEGUIRE le INDICAZIONI della SOREU

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

ANPAS



118

Emergenza 112

SS
E

CONCLUSIONI

LE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI ESORDISCONO IN MODO RAPIDO, IL LORO RICONOSCIMENTO PRECOCE E IL TRASPORTO ALL'OSPEDALE PIÙ IDONEO, PERMETTONO DI POTERE INTERVENIRE CON TERAPIE CHE POSSONO RIDURRE NOTEVOLMENTE GLI ESITI INVALIDANTI.

ANPAS

118

Emergenza 112